ORIGEM DO DOCUMENTO:	Gerência de Farmácia		
TÍTULO:			Nº DOC:
Protocolo - PRT: Protocolo Básico de Farmácia Clínica			PRT.GFARMA.001
DATA 1º VERSÃO	DATA DESTA VERSÃO	VERSÃO Nº	PRÓXIMA REVISÃO
08/12/2025	15/12/2025	01	15/12/2027

1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer as diretrizes mínimas para implementação e execução das atividades de Farmácia Clínica em enfermarias selecionadas, considerando a atual limitação de recursos humanos e priorizando ações de maior impacto na segurança do paciente oncológico.

1.2. Promover a segurança do paciente oncológico por meio da identificação, prevenção e resolução de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs).

1.3. Garantir o uso racional de medicamentos, especialmente aqueles de alto risco, antimicrobianos restritos e antineoplásicos.

1.4. Padronizar o registro das Intervenções Farmacêuticas (IF) e fortalecer a comunicação multiprofissional.

2. ABRANGÊNCIA

2.1. **Critérios de Inclusão:**

- Os pacientes elegíveis para acompanhamento da Farmácia Clínica são aqueles internados na UTI Adulto na Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCECON).

2.2. **Critérios de Exclusão:**

- Paciente em cuidados exclusivamente paliativos sem intervenção medicamentosa ativa.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******** em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

3. FLUXO / CONDUTA PADRONIZADA

Os pacientes elegíveis para acompanhamento da Farmácia Clínica são aqueles internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCECON)..

Para iniciar a avaliação, o farmacêutico clínico deve acessar o sistema SALUX e extrair o censo dos pacientes internados no CTI, incluindo nome, data de nascimento, número do prontuário ou BE e leito. Esses dados devem ser exportados para uma planilha em Excel e inseridos na Planilha de Acompanhamento Farmacoterapêutico, permitindo a quantificação do número de pacientes acompanhados e dos medicamentos prescritos.

Antes da visita multiprofissional, os médicos do CTI realizam as prescrições dos pacientes por meio do sistema. Após a finalização das prescrições, o farmacêutico clínico inicia o processo de triagem. Essa triagem consiste em uma análise criteriosa dos medicamentos prescritos, considerando aspectos como:

• Medicamentos em duplicidade: Observar se na prescrição há duplicidade de medicamentos (um mesmo medicamento prescrito em duplicidade, na mesma dose e forma farmacêutica ou em dose e forma farmacêutica diferentes).

• Medicamento prescrito errado: Analisar se há medicamento prescrito errado, observando os critérios LASA e medicamentos posologias diferentes das usuais. Medicamento com a mesma indicação: Observar se há medicamentos diferentes prescritos para a mesma indicação, ou da mesma classe terapêutica, onde não há evidência do uso concomitante (Heparina e Enoxaparina, Omeprazol e Ranitidina, Micafungina e Anidulafungina).

• Dose incorreta: Avaliar se a dose do medicamento prescrito está correta.

• Intervalo entre as doses inadequado: Analisar se o intervalo entre as doses está correto. Verificar a frequência em que os medicamentos estão prescritos: 6/6h, 8/8h, 12/12h, 72/72h, 1 vez ao dia, 1 vez por semana, 3 vezes por semana. Verificar se há informações obrigatórias da prescrição que estão inseridas em campos inadequados, como informações de “se necessário, se náuseas, se dor”

• Tempo de Tratamento inadequado: Analisar se o tempo de tratamento prescrito está de acordo com a indicação, principalmente antibioticoprofilaxia, medicamentos de pulsoterapia e medicamentos de dose única.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******* em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

• Aprazamento inadequado: Avaliar se o aprazamento dos medicamentos está de acordo com as recomendações de uso, considerando os medicamentos que devem ser administrados em jejum, junto às refeições ou à noite.

• Via de administração: Analisar se a via de administração dos medicamentos prescritos é a mais adequada, considerando as indicações de uso de cada medicamento e a osmolaridade, no caso de medicamentos injetáveis, considerando o tipo acesso que o paciente possui (acesso venoso central, acesso venoso periférico e sondas de alimentação).

• Terapia sequencial: Verificar se dentre os medicamentos prescritos há possibilidade de substituição da terapia endovenosa pela de terapia oral, observando se o paciente está em processo progressivo de melhora clínica, com perspectiva de redução dos dispositivos intravenosos e com o trato gastrointestinal funcionante.

• Adequação de forma farmacêutica: Avaliar se a forma farmacêutica dos medicamentos prescritos é a mais adequada (observar se o paciente está com sonda nasoenteral, orogástria ou gastrostomia e se possui prescrito medicamentos sólidos orais que podem ser substituídos por soluções orais, suspensões e xaropes do mesmo princípio ativo, minimizando assim o risco de obstrução da sonda e trituração do medicamento em gral e pistilo).

• Diluição inadequada: Verificar se o diluente prescrito é o mais adequado e se o volume de diluição está correto.

• Substituição de medicamento em falta: Verificar se há possibilidade de substituição de um medicamento prescrito que está em falta por outro medicamento padronizado.

• Substituição de medicamento com equivalente terapêutico: Verificar se há medicamento prescrito com estoque indisponível por se tratar de medicamento padronizado com equivalente terapêutico.

• Substituição de medicamento não padronizado: Verificar se há medicamento prescrito não padronizado que pode ser substituído por um medicamento padronizado na instituição.

• Alergia: Observar na prescrição se há medicamentos prescritos que já resultaram em processo alérgico anterior ao paciente, observando a presença da sinalização de alergias na prescrição.

• Interação Medicamento X Medicamento: Observar se na prescrição há interações medicamentosas que podem comprometer o tratamento ou a segurança do paciente.

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******* em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

• Interação Medicamento X Alimento: Observar se na prescrição há interações entre medicamentos e alimentos que podem comprometer o tratamento ou a segurança do paciente.

• Incompatibilidade físico-química: Observar se na prescrição há medicamentos, diluentes ou embalagens que apresentam incompatibilidade físico-química.

Após a finalização de todas as prescrições, o farmacêutico clínico se dirige ao setor para participar da visita multiprofissional. Durante a visita, são discutidas as adequações necessárias em cada prescrição, como inclusão, suspensão ou substituição de medicamentos. O farmacêutico contribui com recomendações baseadas em evidências, garantindo que as intervenções farmacológicas estejam alinhadas às melhores práticas clínicas.

Durante a análise, o farmacêutico clínico monitora aspectos essenciais, incluindo: Profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV), Adequação da posologia de inibidores de bomba de prótons (IBPs), Profilaxia de úlceras de córnea em pacientes sedados ou em ventilação mecânica, Data prevista para a descontinuação de antibióticos, Necessidade de descalonamento ou escalonamento da terapia antimicrobiana, Possibilidade de conversão da via de administração para enteral, sempre que viável. Além disso, o farmacêutico clínico verifica o uso racional de medicamentos, acompanha possíveis reações adversas, efeitos colaterais e alergias, intervindo sempre que necessário para garantir a segurança e a eficácia da terapia medicamentosa.

Após a visita, o farmacêutico retorna ao setor e realiza as alterações necessárias nas prescrições, conforme discutido. Em seguida, libera a dispensação para que o técnico de farmácia prepare a separação dos medicamentos para um período de 24 horas. O farmacêutico também registra a evolução farmacêutica no sistema, utilizando o modelo padronizado (Anexo I) e os modelos de mensagens ao prescritor (Anexo III). Em caso de intervenção farmacêutica, esta deve ser detalhada na evolução e registrada na aba de intervenções da Planilha de Acompanhamento Farmacoterapêutico (Anexo II), possibilitando sua avaliação para os indicadores de desempenho. Serão acompanhados os seguintes indicadores:

Taxa de adesão as intervenções farmacêuticas.

Taxa de avaliação farmacêutica.

Taxa de Intervenções Farmacêuticas.

Tipos de Intervenções Farmacêuticas.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******** em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Farmacêutico Clínico

- Realizar revisão sistemática das prescrições.
- Identificar PRMs e propor intervenções.
- Comunicar equipe médica e de enfermagem.
- Registrar todas as ações realizadas.
- Participar de rounds e reuniões assistenciais.

4.2. Gerência do Serviço de Farmácia

- Disponibilizar ferramentas e formulários padronizados.
- Organizar escala e priorização conforme RH disponível.
- Monitorar indicadores e relatar desempenho à direção.
- Atualizar o protocolo semestralmente.

4.3. Equipe Médica

- Avaliar recomendações farmacêuticas.
- Comunicar necessidade de ajustes terapêuticos.
- Registrar qualquer modificação decorrente da intervenção.

4.4. Equipe de Enfermagem

- Executar administração correta dos medicamentos.
- Informar alterações clínicas ou intercorrências relacionadas à farmacoterapia.
- Auxiliar na implementação de medidas de segurança.

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******** em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

5. REFERÊNCIAS

- American Society of Health-System Pharmacists (ASHP). ASHP Guidelines on Clinical Pharmacy Services.
- Institute for Safe Medication Practices (ISMP). High-Alert Medications List.
- Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care.
- Ministério da Saúde. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
- Ministério da Saúde. Programa Nacional de Segurança do Paciente – Portaria MS nº 529/2013.
- Resolução CFF nº 585/2013 – Atribuições clínicas do farmacêutico.
- Resolução CFF nº 586/2013 – Prescrição farmacêutica.
- Instituto para Melhoria da Saúde (IHI) – Diretrizes de Segurança Medicamentosa.

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******** em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

ANEXOS

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******** em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

ANEXO 1 – FICHA DE REGISTRO DA INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA

MODELO DE INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA - SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA

Paciente:_____

Data de Nascimento: __/__/__ **Setor/ Leito:** _____ **Data:** __/__/__

EVOLUÇÃO FARMÁCIA CLÍNICA - ADMISSÃO

1. Diagnóstico(s) Principal(is) / Condição Clínica Atual: *(Registrar diagnóstico(s) médico(s) ou hipótese(s) clínica(s) relevante(s) para a farmacoterapia)*

2. Histórico Clínico Relevante: *(Comorbidades, dispositivos invasivos, condições que impactem a terapia medicamentosa)*

3. Alergias Medicamentosas: *(Registrar alergias relatadas ou "Nega", conforme prontuário)*

4. Peso / Idade (quando aplicável): *(Informar dados necessários para cálculo de dose)*

RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA *(Realizar na admissão, transferência e alta)*

Uso prévio de medicamentos:

☐ **Sim** ☐ **Não**

Se sim, descrever: *(Nome do medicamento, dose, posologia e fonte da informação)*

MEDICAMENTOS EM USO *(Transcrever medicamentos prescritos relevantes para avaliação clínica)*

Medicamento Dose Posologia Via

ANTIMICROBIANOS *(Preencher quando aplicável)*

Antimicrobiano(s) em uso: *(Nome, dose, posologia, dia de tratamento – D/D)*

EXAMES LABORATORIAIS *(Registrar apenas exames que impactem a farmacoterapia)*

Creatinina / ClCr: _____

Eletrólitos: _____

Hemograma: _____

Outros: _____

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******** em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA

Descrição da intervenção: *(Descrever de forma objetiva a orientação ou ajuste proposto)*

Intervenção aceita?

☐ **Sim** ☐ **Não**

Justificativa (quando não aceita):

PLANO / RECOMENDAÇÕES FARMACÊUTICAS

(Registrar orientações, monitoramento proposto ou condutas sugeridas)

Assinatura / Identificação do Farmacêutico(a):

ANEXO 2 – PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO

ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO

Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCECON) - UTI ADULTO

Farmacêutico responsável:

Mês: JANEIRO	TRIAGEM FARMACÊUTICA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Número total de Pacientes Avaliados	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Número de medicamentos prescritos	40	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
Número de medicamentos prescritos com ERRO	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Tipos de erros de medicamentos prescritos																																
Forma Farmacêutica																																0
Dose																																0
Posologia (Frequência)																																0
Via de administração																																0
Diluição																																0
Aprazamento																																0
Medicamento Não Padrão - Substituição																																
Duplicidade																																0
Ilegibilidade																																0
Não Conformidades na Identificação e Documentação da Prescrição																																0
Alergia																																0
Reação Adversa																																0
Reconciliação Medicamentosa																																0
Interações Medicamentosas																																0
Tempo de terapia																																0
Solicitação de exames																																0
Inclusão de Medicamento																																0
Outros																																0
Observações:																																

Triagem Farmacêutica | Censo | Intervenções | Listas

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******* em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

ANEXO 3 – MODELOS DE MENSAGENS AO PRESCRITOR

MODELOS PADRONIZADOS

1. Ajuste de Dose – Função Renal / Hepática

“Dr(a). ___, boa tarde! Durante revisão da prescrição do paciente ___ (leito ___), identifiquei que o medicamento ___ está acima/abaixo da dose recomendada para a função renal/hepática atual. Sugiro ajustar para ___ conforme diretrizes. Permaneço à disposição.”

2. Interação Medicamentosa Relevante

“Dr(a). ___, identificada interação clinicamente significativa entre ___ e ___. Há risco potencial de ___. Sugiro avaliar ajuste de dose/substituição para ___. Caso deseje, posso auxiliar na monitorização.”

3. Duplicidade Terapêutica

“Dr(a). ___, observei duplicidade terapêutica entre ___ e ___. Sugiro manter apenas ___, a fim de evitar efeitos adversos e otimizar a terapia. Fico à disposição.”

4. Segurança em Antineoplásicos

“Dr(a). ___, revisei o esquema antineoplásico do paciente ___ e identifiquei possível divergência referente a ___. Sugiro revisão imediata para garantir segurança. Já sinalizei a enfermagem. Permaneço disponível.”

5. Antimicrobiano de Uso Restrito

“Dr(a). ___, paciente ___ em uso de ___ (restrito). Considerando parâmetros clínicos e culturais, sugiro reavaliar manutenção/ajuste/descalonamento. Posso apoiar na escolha terapêutica.”

6. Reação Adversa Suspeita

“Dr(a). ___, paciente ___ apresentou sinais compatíveis com reação adversa possivelmente relacionada a ___. Sugiro avaliar substituição e monitorização de ___. Aguardo orientação.”

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******** em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.

7. Medicamento Não Padronizado

"Dr(a). ___, o medicamento ___ não integra a padronização institucional. Sugiro alternativa terapêutica padronizada como ___. Caso mantenha indicação, posso auxiliar na justificativa formal."

8. Situação de Urgência – Risco Alto

"Dr(a). ___, urgência: identifiquei risco potencial ao paciente ___ relacionado ao uso de ___. Sugiro suspensão imediata e revisão da conduta. Enfermagem já alertada."

9. Alteração Clínica que Exige Reavaliação Terapêutica

"Dr(a). ___, houve alteração recente de ___ (ex.: creatinina, bilirrubina) no paciente ___, o que impacta a terapia com ___. Sugiro ajustar dose para ___. Posso acompanhar evolução laboratorial."

10. Mensagem Apreciativa (fortalece vínculo multiprofissional)

"Dr(a). ___, agradeço pela análise da recomendação. Essa integração fortalece a segurança do paciente. Sigo à disposição."

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	08/12/2025	Elaboração do POP

Elaboração: **Kacio Felipe Silva Souza** – Farmacêutico Clínico / CRF-AM2639 Assinatura: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:52666042200 Assinado de forma digital por KACIO FELIPE SILVA SOUZA:52666042200	Data: 15/12/2025
Aprovação: **Hilka Flávia Barra do Espírito Santo Alves Pereira** – Diretora Técnica Assinatura: HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253	Data: 15/12/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/811B.FE9B.E1D0.4677/A510B42E
Código verificador: **811B.FE9B.E1D0.4677** CRC: **A510B42E**

Documento 811B.FE9B.E1D0.4677 assinado por: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:526******* em 18/12/2025 às 17:49 utilizando assinatura por login/senha.